



1 de 40



1. Una mujer de 72 años consulta por dolor y rigidez en los hombros y caderas de varias semanas de evolución. Refiere que los síntomas son más intensos en la mañana y mejoran con la actividad. No presenta artritis evidente ni debilidad muscular. En los exámenes de laboratorio se observa VHS 65 mm/h (VN: < 20mm/h), PCR 25 mg/L (VN: <5 mg/L), hemoglobina 11.5 g/dL y creatinina 0.9 mg/dL.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Mostrar resultados

0/60 Los Estudiantes Respondieron



- A Polimialgia reumática
- B Dermatomiositis
- C Fibromialgia
- D Artritis reumatoide
- E Polimiositis

A

i Mostrar explicación

2. Mujer de 68 años, hipertensa, consulta por dolor y rigidez matinal en hombros y caderas, al que se suma malestar general en las últimas semanas, sin fiebre ni pérdida de peso. En el examen físico, no se observa debilidad muscular ni signos de artritis. El laboratorio muestra una VHS de 45mm/hr y una PCR de 45mg/Lt.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron



- | | | |
|-----|-------------------|-----|
| A | Paracetamol | 11% |
| ✓ B | Prednisona | 74% |
| C | Metotrexato | 11% |
| D | Hidroxicloroquina | 2% |
| E | Fisioterapia | 2% |

i Mostrar explicación

3. Mujer de 72 años, diabética, consulta por cefalea intensa unilateral en la región temporal derecha, de inicio hace dos semanas, junto con dolor en la mandíbula al masticar y **visión borrosa intermitente** en el ojo derecho. También refiere una pérdida de peso no intencionada de 5Kg y dolor en hombros y caderas al despertar. En su laboratorio destaca VHS de 85 mm/h, PCR 40 mg/L y hemoglobina 10.5 g/dL.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

48/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Migraña con aura	0%
B	Neuralgia del trigémino	2%
C	Cefalea tensional	2%
✓ D	Arteritis de la temporal	96%
E	Lupus eritematoso sistémico	0%

i Mostrar explicación ▾

4. Mujer de 80 años, hipertensa, consulta por cefalea intensa en la región temporal izquierda, junto con dolor mandibular al masticar y visión borrosa intermitente en el ojo izquierdo. Al examen nota una arteria temporal izquierda indurada y dolorosa, la que se asocia a una VHS de 90mm/Hr.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados

49/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Ecografía doppler de la arteria temporal	51%
B	Biopsia de la arteria temporal	20%
C	Tomografía computarizada de cerebro contrastada	18%
D	Angiografía por resonancia magnética	8%
E	Punción lumbar bajo anestesia local	2%

i Mostrar explicación ▾

5. Mujer de 81 años, consulta por cefalea intensa frontal derecha, claudicación mandibular y visión borrosa en el ojo derecho desde hace tres días. Al examen físico, se palpa la arteria temporal derecha indurada y dolorosa, y presenta una disminución de la agudeza visual en el ojo afectado. Una PCR fue de 55mg/Lt y la VHS alcanzó los 85mm/Hr.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Metilprednisolona	98%
B	Metotrexato	2%
C	Azatioprina	0%
D	Hidroxicloroquina	0%
E	Tocilizumab	0%

i Mostrar explicación ▾

6. Mujer de 45 años, con antecedente de depresión, consulta por dolores muscular difuso e insomnio de 6 meses de evolución. Refiera que el dolor no mejora con el reposo y se intensifica con el estrés. En la exploración física se observa sensibilidad aumentada en múltiples puntos gatillo, pero **sin signos de artritis** ni debilidad muscular. Sus exámenes de laboratorio, incluyendo hemograma, VHS, PCR y pruebas de función tiroidea, son normales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

51/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Polimiositis	0%
B	Artritis reumatoide	4%
✓ C	Fibromialgia	96%
D	Espondiloartropatía seronegativa	0%
E	Osteoartritis	0%

i Mostrar explicación ▾

7. Mujer de 51 años, hipertensa, consulta por dolor musculoesquelético difuso y alteraciones del sueño que han afectado su calidad de vida en los últimos seis meses. Está muy frustrada, puesto ha ido con varios médicos que "no le encuentran nada". Al examen, nota múltiples puntos gatillo dolorosos en múltiples zonas, pero sin signos de artritis ni debilidad muscular. Su laboratorio es normal.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

51/60 Los Estudiantes Respondieron



✓ A	Duloxetina	73%
B	Tramadol	2%
C	Paracetamol	18%
D	Hidroxiclорокина	0%
E	Ibuprofeno	8%

8. Hombre de 28 años, previamente sano, consulta por dolor lumbar de más de seis meses de evolución, que se presenta de manera insidiosa, mejora siempre que hace deporte y empeora con el reposo, a veces despertándolo por la noche. También refiere rigidez matutina de 30-45 minutos. En su laboratorio nota una PCR de 22mg/Lt y una VHS de 40mm/Hr.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

53/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Artritis reactiva	17%
✓ B	Espondilitis anquilosante	70%
C	Lumbago mecánico	6%
D	Fibromialgia	0%
E	Hernia discal lumbar	8%

i Mostrar explicación ▾

9. Un hombre de 30 años consulta por dolor lumbar crónico de más de seis meses de evolución, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física. También presenta rigidez matutina prolongada y episodios de dolor en glúteos alternante. En el examen físico, se observa disminución de la movilidad lumbar y una prueba de Schober resulta positiva.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados

51/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Radiografía de columna lumbar	25%
B	Tomografía axial computarizada de columna	6%
✓ C	Resonancia magnética de columna	39%
D	Factor reumatoideo	18%
E	Anticuerpos antinucleares	12%

i Mostrar explicación

10. Hombre de 34 años, consulta por dolor lumbar de 5 meses de evolución que lo despierta por la noche y se ha asociado a rigidez matinal. Se solicitó una radiografía de columna que se muestra en la imagen.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

48/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Osteoartritis de columna	10%
B	Artritis reumatoide	2%
C	Artritis reactiva	0%
D	Artritis psoriásica	2%
✓ E	Espondilitis anquilosante	85%

i Mostrar explicación



11. Hombre de 30 años, previamente sano, consulta por dolor lumbar crónico de más de seis meses de evolución, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física. No ha tenido respuesta con ibuprofeno oral. También refiere rigidez matutina prolongada y episodios de dolor en glúteos alternante. Una resonancia magnética de sacroilíacas confirma sacroilitis bilateral y en el laboratorio nota VHS de 45mm/hr con alza de PCR a 45mg/Lt.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

47/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Paracetamol	2%
B	Prednisona	57%
C	Metotrexato	13%
D	Sulfasalazina	9%
✓ E	Etanercept	19%

i Mostrar explicación ▾

12. Hombre de 26 años consulta por dolor lumbar de inicio reciente, que empeora con el reposo y mejora con la actividad física. Hace tres semanas presentó diarrea autolimitada y, desde entonces, ha notado dolor de la rodilla derecha y en el tobillo izquierdo. Al examen físico nota conjuntivitis leve, edema en el tendón de Aquiles derecho y movilidad lumbar reducida.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

47/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Osteoartritis	0%
B	Espondilitis anquilosante	0%
C	Artritis reumatoide	2%
✓ D	Artritis reactiva	89%
E	Espondilopatía enteropática	9%

i Mostrar explicación ▾



13 de 40



13. Hombre de 48 años, previamente sano, consulta por debilidad progresiva de brazos y piernas en los últimos tres meses. Refiere dificultad para subir escaleras y levantar objetos por encima de la cabeza, pero niega síntomas sensitivos. En el examen físico, presenta fuerza disminuida en los músculos proximales, sin atrofia, y los reflejos osteotendinosos están conservados.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Mostrar resultados

49/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Anticuerpos antinucleares	20%
B	Factor reumatoideo	14%
✓ C	Creatininkinasa total	57%
D	Resonancia magnética	2%
E	Complemento sérico	6%

i Mostrar explicación ▾

15. Hombre de 50 años, consulta por debilidad progresiva en los músculos proximales de brazos y piernas en los últimos tres meses, dificultándole subir escaleras. Al examen sólo destaca dificultad para levantarse a la camilla. En su laboratorio nota una CK de 2,000 U/L, así como una PCR de 35mg/Lt (VN<5mg/Lt).

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Prednisona	76%
B	Metotrexato	4%
C	Leflunomida	7%
D	Inmunoglobulinas intravenosas	2%
E	Infliximab	11%

i Mostrar explicación

< 16 de 40 >

16. Mujer de 26 años, consulta por debilidad de extremidades de 3 meses de evolución. Durante las últimas semanas ha notado aparición de un exantema que se muestra en la imagen.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?



Ocultar resultados

52/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Rosácea	2%
B	Lupus eritematoso sistémico	38%
✓ C	Dermatomiositis	54%
D	Blefaritis crónica	2%
E	Esclerosis sistémica	4%

i Mostrar explicación

17. Hombre de 72 años, con antecedente de dermatomiositis en tratamiento inmunosupresor, consulta por tos persistente de 4 meses de evolución. Refiere que en las últimas semanas ésta se asoció a esputo hemoptoico.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

Ocultar resultados

48/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Iniciar azitromicina por vía oral	4%
B	Solicitar un ecocardiograma transtorácico	6%
C	Solicitar un test de liberación de interferón para tuberculosis	33%
✓ D	Solicitar una tomografía computarizada de tórax	50%
E	Tranquilizar al paciente y controlar en 3 meses más	6%

i Mostrar explicación ▾

18. Hombre de 45 años consulta por disnea progresiva, debilidad muscular proximal y artralgias de varios meses de evolución. Refiere también episodios de fiebre y manos violáceas con el frío. En la exploración destaca debilidad en cintura escapular y pélvica, además de dedos engrosados y agrietados con fisuras en las puntas. Una radiografía de tórax muestra patrón intersticial basal y en laboratorio la CK es de 2.500UI/L.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

49/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Síndrome de Sjögren	10%
B	Esclerosis sistémica	53%
✓ C	Síndrome antisintetasa	22%
D	Vasculitis sistémica	14%
E	Polimiositis	0%

i Mostrar explicación ▼

19. Una mujer de 45 años consulta por rigidez y engrosamiento progresivo de la piel en manos y cara, junto con decoloración violácea de las manos siempre que se expone al frío, como al lavar los platos. Al examen físico nota presenta piel tensa con pérdida de pliegues en los dedos y telangiectasias en rostro y manos.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados 49/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Anticuerpos antinucleares	61%
B	Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo	6%
C	Anticuerpos anti-DNA	22%
D	Anticuerpos antiestreptolisina	4%
E	Anticuerpos anti-Jo1	6%

i Mostrar explicación ▾

20. Una mujer de 50 años consulta por cambios de color en los dedos de la mano derecha desencadenados por el frío, que inician con palidez, seguidos de cianosis y eritema. Con frecuencia siente dolor a nivel durante las crisis. Al examen, nota áreas necróticas y ulceradas en el índice y dedo medio derechos. Una capilaroscopia muestra capilares dilatados y áreas de avascularidad.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

50/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Enfermedad de Raynaud	62%
B	Lupus eritematoso sistémico	0%
✓ C	Esclerosis sistémica limitada	38%
D	Dermatomiositis	0%
E	Artritis reumatoidea	0%

i Mostrar explicación ▾

21. Mujer de 67 años, hipertensa y con antecedentes de esclerosis sistémica limitada, consulta por tos y disnea de esfuerzos de 6 meses de evolución. Refiere que nota que no puede correr y a ratos tiene dificultades para caminar grandes distancias. Al examen físico destaca edema bimalleolar con fóvea.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados

34/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Ecocardiograma transtorácico	41%
B	Radiografía de tórax posteroanterior	21%
C	Tomografía computarizada de tórax sin contraste	26%
D	Angiotomografía computarizada de tórax	9%
E	Niveles de creatinina en sangre	3%

i Mostrar explicación ▾

22. Una mujer de 42 años, secretaria, consulta por dolor en las articulaciones de las manos y muñecas, que mejora mientras trabaja de 3 meses de evolución. Describe además rigidez matinal de 1 hora durante los últimos meses. Al examen físico, se observan articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas proximales tumefactas y dolorosas, con limitación de la movilidad, pero sin afectación de interfalángicas distales

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron



✓ A	Artritis reumatoide	85%
B	Artritis psoriásica	2%
C	Artritis reactiva	0%
D	Osteoartritis	9%
E	Condrocalcinosis	4%

i Mostrar explicación ▾

23. Mujer de 44 años, sana, consulta por dolor en articulaciones de las manos y muñecas desde hace seis meses. Al examen, nota poliartritis simétrica en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, sin afectación de interfalángicas distales, sumando 8 articulaciones en total. Los exámenes de laboratorio muestran PCR 18 mg/L, mientras que las radiografías de manos muestran estrechamiento del espacio articular y erosiones óseas iniciales. El factor reumatoideo fue negativo.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Prednisona exclusiva	4%
✓ B	Metotrexato y diclofenaco	72%
C	Prednisona y paracetamol	17%
D	Hidroxicloroquina y celecoxib	7%
E	Metilprednisolona y paracetamol	0%

i Mostrar explicación ▼

24. Mujer de 32 años, con diagnóstico de artritis reumatoide, acude a consulta para control de su enfermedad. Actualmente, se encuentra en la semana 10 de gestación y ha suspendido su tratamiento por temor a efectos adversos en el feto. En las últimas semanas ha presentado dolor e inflamación en las articulaciones metacarpofalángicas y muñecas, con rigidez matutina prolongada.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

41/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Metotrexato	2%
✓ B	Prednisona	0%
C	Hidroxicloroquina	98%
D	Leflunomida	0%
E	Micofenolato mofetil	0%

i Mostrar explicación ▾

25. Mujer de 56 años, con artritis reumatoide de larga evolución consulta por pérdida de peso y episodios recurrentes de infecciones en los últimos meses. Al examen destaca hepatoesplenomegalia y artritis en muñecas y metacarpofalángicas. Los exámenes muestran leucocitos $2,000/\text{mm}^3$ con 30% de neutrófilos, Hb 10 g/dL, plaquetas $130,000/\text{mm}^3$ y factor reumatoide intensamente positivo.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

41/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Lupus eritematoso sistémico	12%
B	Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos	32%
✓ C	Síndrome de Felty	46%
D	Enfermedad mixta del tejido conectivo	5%
E	Artritis psoriásica mutilante	5%

i Mostrar explicación

26. Mujer de 65 años, diabética, consulta por dolor en ambas manos que ha empeorado en los últimos años. Refiere rigidez matutina de 10-15 minutos y aumento del dolor con el uso de las articulaciones. Al examen físico, presenta nódulos duros en las articulaciones interfalángicas distales y proximales.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

45/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Artritis reumatoide	7%
✓ B	Osteoartritis	84%
C	Artritis reactiva	0%
D	Condrocálcinosis	4%
E	Artritis psoriásica	4%

i Mostrar explicación

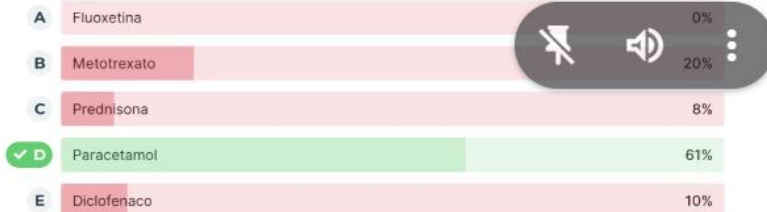
27. Mujer de 80 años, hipertensa, consulta por dolor de ambas manos de 6 meses de evolución. Trae una radiografía que se muestra en la imagen.

¿Cuál es el tratamiento de elección?



Ocultar resultados

49/60 Los Estudiantes Respondieron

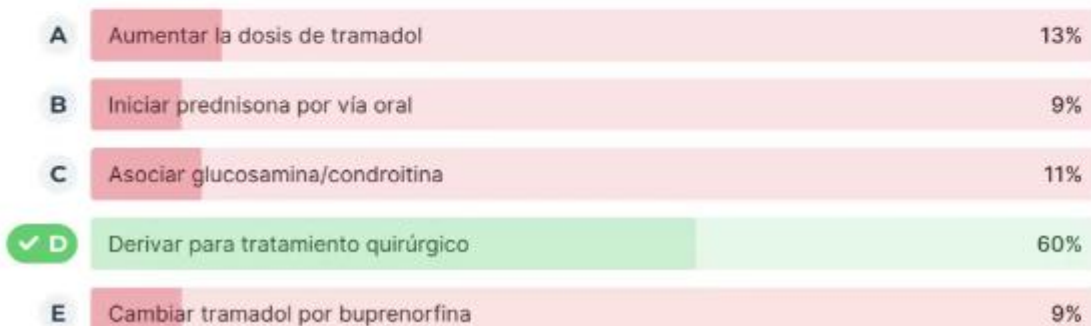


28. Hombre de 68 años con antecedente de osteoartritis de rodilla, acude a control. Persiste con dolor intenso y rigidez progresiva en ambas rodillas que ha limitado sus actividades diarias. Ha recibido tratamiento con paracetamol/tramadol, fisioterapia y reducción de peso, con alivio parcial, pero en los últimos meses el dolor ha empeorado, hasta presentarse en reposo. En la exploración física, presenta crepitación articular, deformidad en varo y limitación severa de la movilidad.

¿Cuál es la conducta más adecuada?

Ocultar resultados

47/60 Los Estudiantes Respondieron



29. Hombre de 28 años, consulta por dolor de la cadera derecha de 8 meses de evolución. Inicialmente, el dolor era intermitente y solo aparecía después de realizar actividad física intensa, pero en los últimos meses ha aumentado en frecuencia e intensidad, afectando sus actividades diarias. Al examen, nota limitación de la movilidad de la cadera, especialmente en la rotación interna. Una radiografía de pelvis muestra signos de displasia del desarrollo de la cadera con insuficiente cobertura acetabular y cambios degenerativos incipientes.

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

47/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Artroplastía parcial de cadera	36%
B	Artroplastía total de cadera	13%
✓ C	Osteotomía acetabular	21%
D	Dexametasona intraarticular	9%
E	Tramadol y paracetamol por vía oral	21%

Mostrar explicación

30. Hombre de 70 años, hipertenso y diabético, consulta por dolor e inflamación aguda en la rodilla. Al examen nota sutil edema y eritema de la rodilla derecha. La artrocentesis muestra líquido sinovial con 15000cels/mm³, asociado a cristales con refringencia positiva. La radiografía evidencia **calcificación en cartilago articular.**

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

48/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Condrocálcinosis	38%
B	Artritis séptica	23%
C	Osteoartritis	0%
D	Artritis reactiva	0%
E	Gota	40%

i Mostrar explicación ▾

31. Hombre de 75 años consulta por severo dolor e inflamación en la rodilla derecha de inicio abrupto. La artrocentesis muestra líquido sinovial con 17,000 leucocitos/mm³, sin cristales de urato. La radiografía revela **calcificación lineal del cartilago articular.**

¿Cuál es el tratamiento de elección?

Ocultar resultados

43/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Paracetamol oral	9%
✓ B	Metilprednisolona intraarticular	58%
C	Prednisona oral	5%
D	Hidroxicloroquina oral	0%
E	Colchicina oral	28%

i Mostrar explicación ▾

32. Un hombre de 27 años, halterofilista, consulta por dolor e inflamación en la rodilla derecha de 5 días de evolución. Niega fiebre o síntomas sistémicos. Al examen físico se observa aumento de volumen localizado en la región anterior de la rodilla, con enrojecimiento leve, marcada sensibilidad a la palpación y movilidad articular conservada, sin inestabilidad articular.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

45/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Artritis séptica	7%
B	Tendinosis rotuliana	29%
C	Osteoartritis de rodilla	2%
D	Rotura del ligamento cruzado anterior	4%
✓ E	Bursitis prepatelar	58%

i Mostrar explicación ▾

33. Hombre de 55 años, consulta por dolor en la región inguinal derecha que se irradia a la cara anterior del muslo. El dolor empeora con la extensión de la cadera y al caminar distancias largas. No hay antecedente de trauma ni signos de inflamación local. Una ecografía muestra colección anecoica bien delimitada anterior a la articulación coxofemoral

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

39/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Osteoartritis	3%
B	Bursitis trocantérea	33%
✓ C	Bursitis iliopectínea	38%
D	Tendinitis del psoas	15%
E	Condrocalcinosis	10%

34. Mujer de 60 años, con historia de osteoartritis, consulta por dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que se irradia hasta el muslo y empeora al caminar o al acostarse sobre el lado afectado. Al examen nota sensibilidad a la palpación del área, sin limitaciones de movilidad.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

43/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Osteoartritis de cadera	2%
✓ B	Bursitis trocantérea	95%
C	Bursitis iliopectínea	2%
D	Tendinitis del psoas	0%
E	Osteonecrosis de la cadera	0%

34. Mujer de 60 años, con historia de osteoartritis, consulta por dolor en la cara lateral de la cadera derecha, que se irradia hasta el muslo y empeora al caminar o al acostarse sobre el lado afectado. Al examen nota sensibilidad a la palpación del área, sin limitaciones de movilidad.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

46/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Osteoartritis de cadera	2%
✓ B	Bursitis trocantérea	96%
C	Bursitis iliopectínea	2%
D	Tendinitis del psoas	0%
E	Osteonecrosis de la cadera	0%

i Mostrar explicación ✓

35. Hombre de 55 años, diabético, consulta por dolor en el hombro derecho que ha empeorado progresivamente en las últimas 3 semanas. El dolor se presenta al levantar el brazo por encima de la cabeza y al acostarse sobre el lado afectado. Al examen, nota un arco doloroso entre 60° y 120° de abducción, con movilidad pasiva normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

41/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Capsulitis adhesiva	2%
B	Osteoartritis acromioclavicular	2%
C	Luxación glenohumeral	2%
D	Tendinosis del redondo menor	0%
✓ E	Tendinosis del supraespinoso	93%

i Mostrar explicación ▾

36. Un hombre de 50 años consulta por dolor en el hombro derecho de 2 meses de evolución, que empeora al levantar el brazo por encima de la cabeza y al dormir sobre el lado afectado. No recuerda traumatismos recientes. Al examen, nota un arco doloroso entre 60° y 100° de abducción y **prueba de Jobe positiva**, sin limitación de la movilidad pasiva.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados

43/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Radiografía de hombro	5%
B	Tomografía computarizada de hombro	5%
C	Resonancia magnética de hombro	9%
D	Artrocentesis glenohumeral	0%
✓ E	Ecotomografía del hombro	81%

 Mostrar explicación ▾

37. Mujer de 35 años, entrenadora de gimnasio, consulta por dolor en la parte superior del hombro derecho, que ha empeorado progresivamente en los últimos meses. El dolor se intensifica con la aducción cruzada del brazo y al levantar pesas. No refiere antecedentes de trauma. En la exploración, la prueba de aducción cruzada es positiva, sin limitación de la movilidad glenohumeral. Una radiografía muestra esclerosis y osteofitos en la articulación acromioclavicular.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

39/60 Los Estudiantes Respondieron



A	Luxación glenohumeral	3%
B	Capsulitis adhesiva	3%
C	Tendinosis del supraespinoso	3%
✓ D	Osteoartritis acromioclavicular	92%
E	Bursitis subacromial	0%

38. Mujer de 48 años con diabetes mellitus consulta por dolor y rigidez progresiva en el hombro izquierdo desde hace seis meses. Refiere dificultad para levantar el brazo y alcanzar objetos por encima de la cabeza. Al examen físico, presenta movilidad reducida en todos los planos, tanto activa como pasiva. La radiografía es normal.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

44/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Bursitis subacromial	2%
B	Síndrome del manguito rotador	32%
C	Luxación glenohumeral crónica	0%
✓ D	Capsulitis adhesiva	66%
E	Osteoartritis acromioclavicular	0%

i Mostrar explicación ✓

39. Mujer de 32 años, con antecedente de dos abortos espontáneos en el segundo trimestre, consulta por dolor y edema en la pierna izquierda de tres días de evolución. Una ecografía doppler confirmó una trombosis venosa profunda.

¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Ocultar resultados

41/60 Los Estudiantes Respondieron

✓ A	Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos	90%
B	Lupus eritematoso sistémico	2%
C	Déficit de proteína C activada	2%
D	Enfermedad mixta del tejido conectivo	0%
E	Vasculitis leucocitoclástica	5%

i Mostrar explicación ✓



40. Mujer de 35 años, con antecedente de lupus eritematoso sistémico y un aborto a las 18 semanas, consulta por dolor y edema en la pierna derecha de tres días de evolución. La ecografía Doppler confirma trombosis venosa profunda.

¿Qué examen solicitaría a continuación?

Ocultar resultados

42/60 Los Estudiantes Respondieron

A	Anticuerpos antinucleares	12%
B	Anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo	5%
C	Anticuerpos anti-DNA bicatenario	5%
✓ D	Anticuerpos anticardiolipinas	74%
E	Anticuerpos anti Jo-1	5%

 Mostrar explicación 